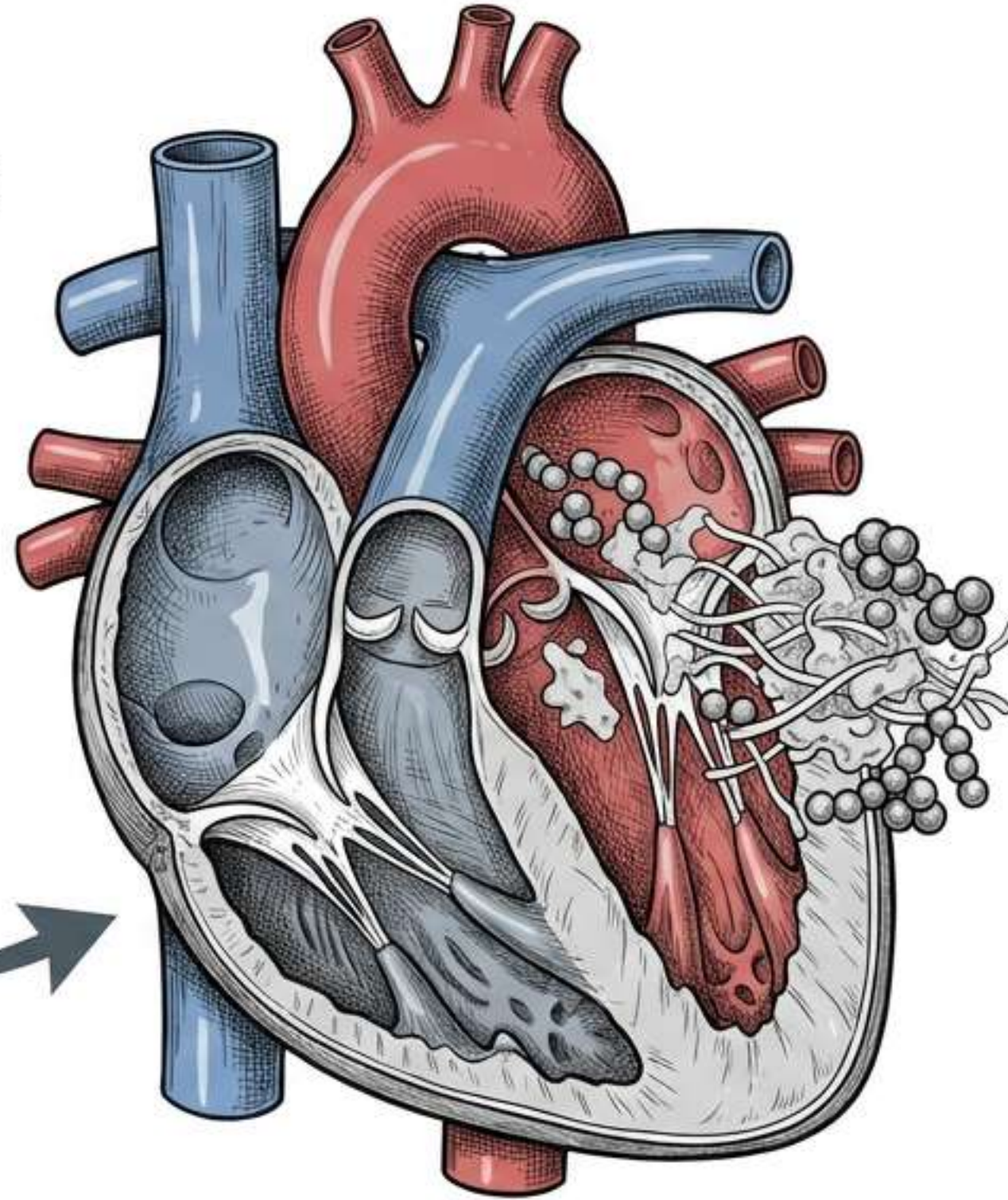


UNIVERSITE D'ALGER
FACULTE DE MEDECINE
ENSEIGNEMENT DE MICROBIOLOGIE
2EME ANNEE DE CHIRURGIE DENTAIRE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023
Dr HENNICHE

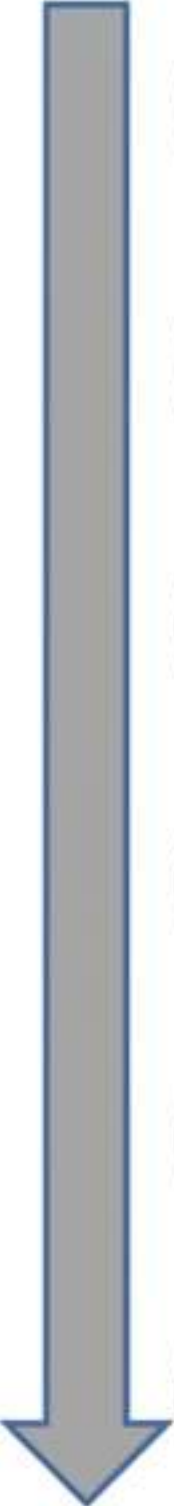
Microbiologie



Chirurgie Dentaire

ENDOCARDITE INFECTIEUSE

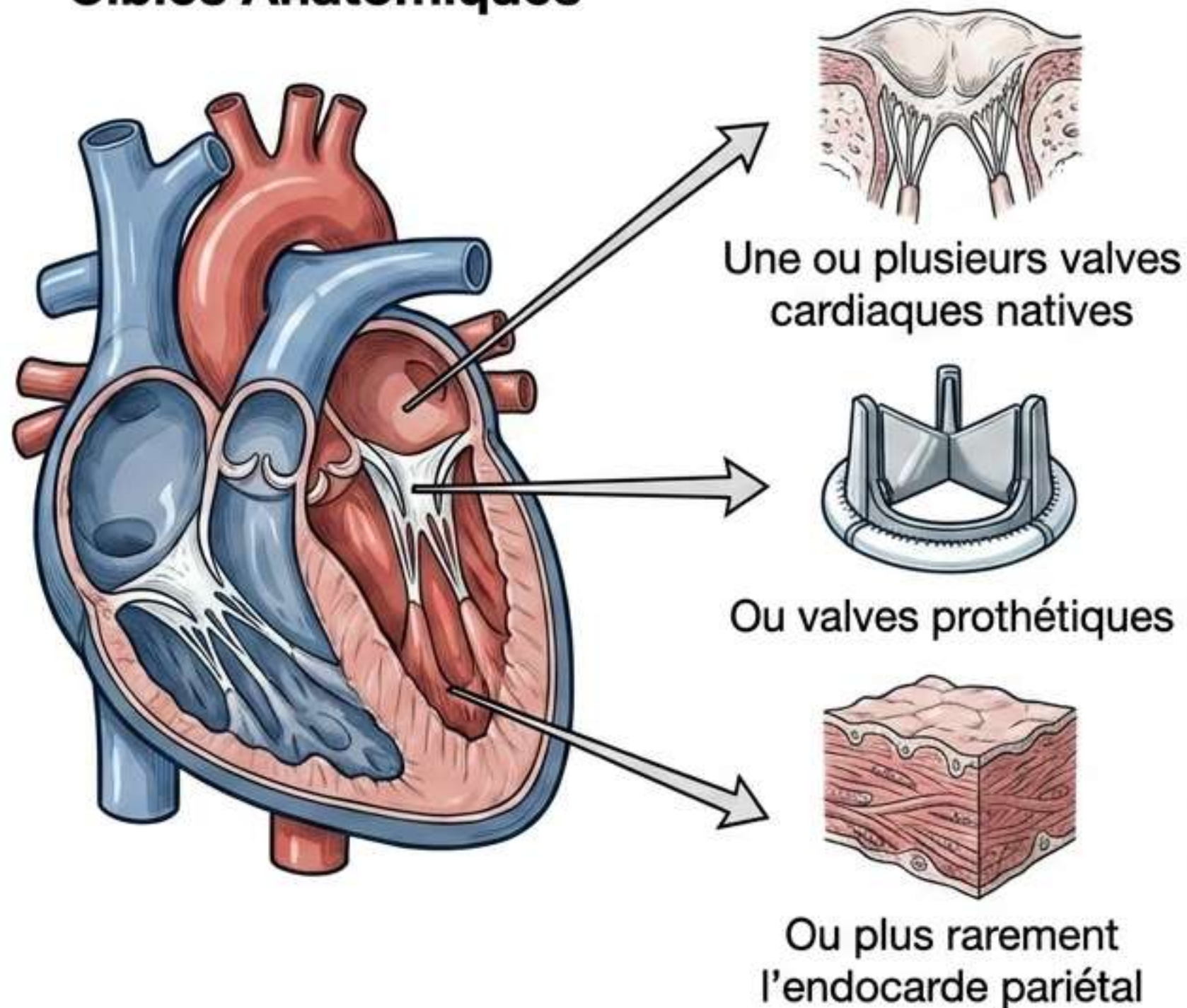
Plan du Cours : L'Endocardite Infectieuse

- 
-  **1. Définition**
 -  **2. Physiopathologie**
 -  **3. Agents Étiologiques**
 -  **4. Diagnostic**
 -  **5. Traitement Antibiotique**
 -  **6. Prophylaxie**

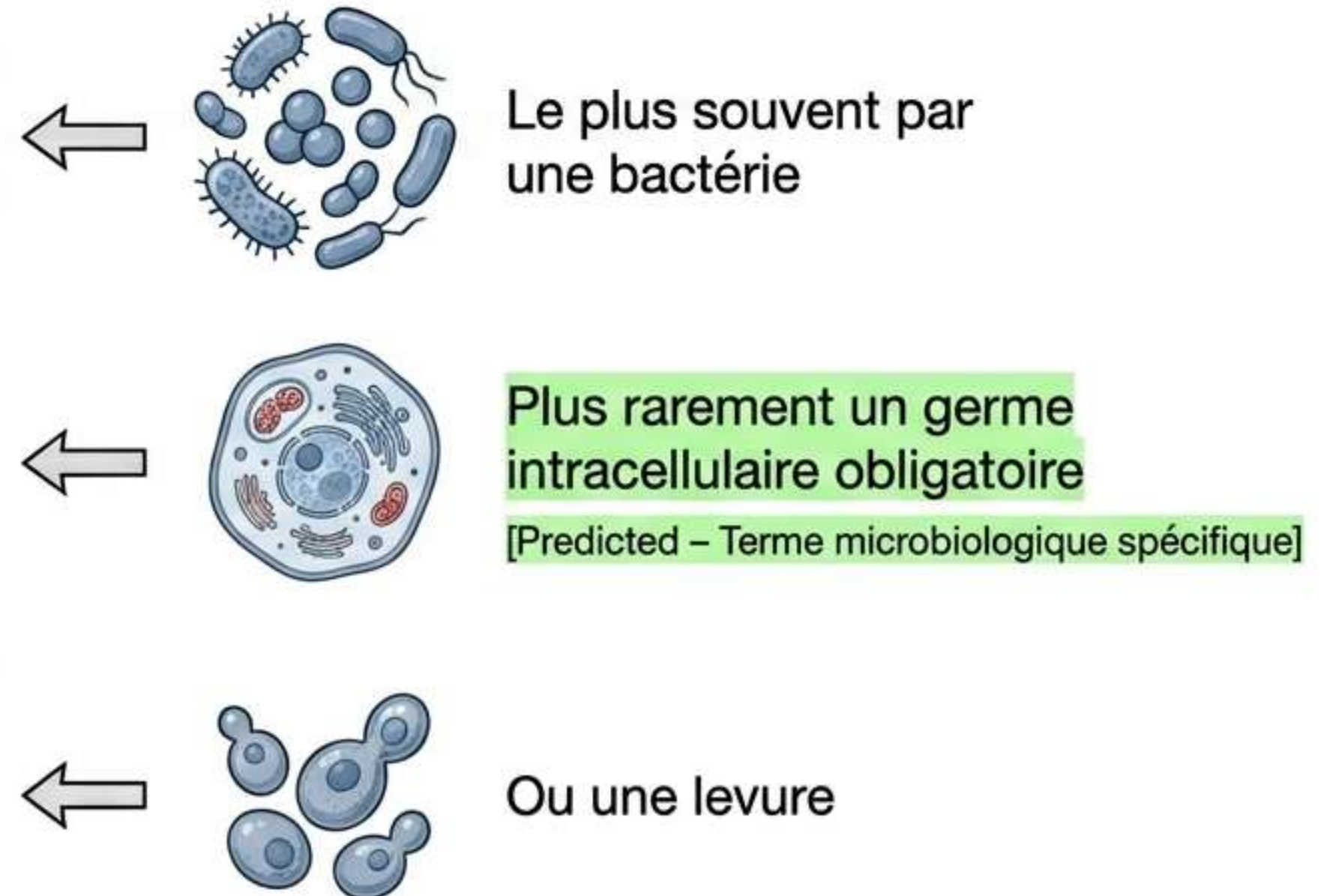
Définition de l'Endocardite Infectieuse

C'est une infection touchant :

Cibles Anatomiques



Agents responsables de l'infection :



Physiopathologie (1/2) : Terrain et Initiation

L'infection nécessite le croisement d'un terrain vulnérable et d'une bactériémie :

1. Terrain sous-jacent :



Valvulopathie
congénitale ou acquise



Prothèse valvulaire

Ou présence de matériel intra cardiaque :



Défibrillateur /
Pacemaker



Cathéter

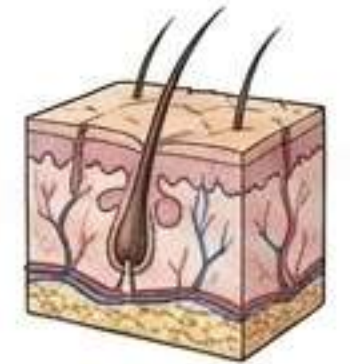
2. Événement déclencheur (Bactériémie) :



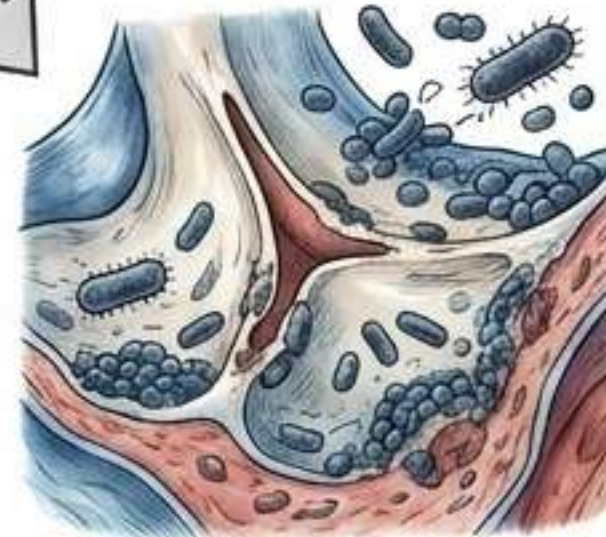
Origine dentaire ^[Predicted]
le plus souvent



Origine
digestive



Origine
cutanée



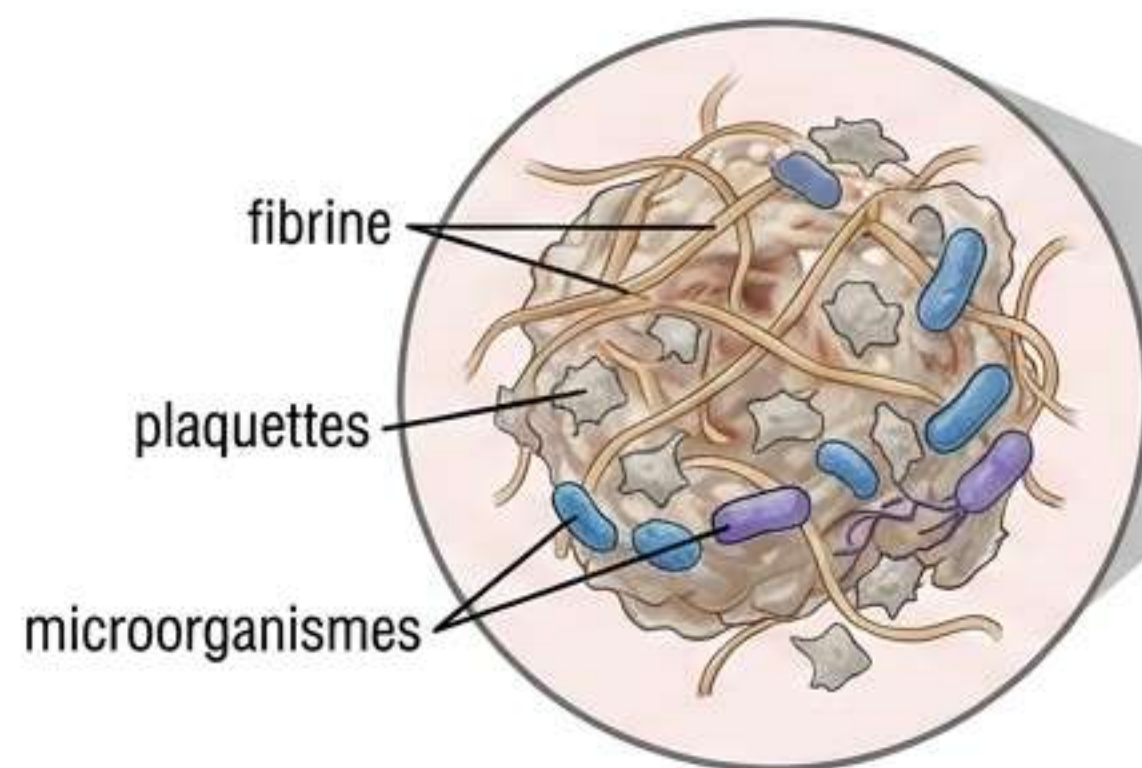
Endocarde et Valves

3. Mécanisme d'Initiation :

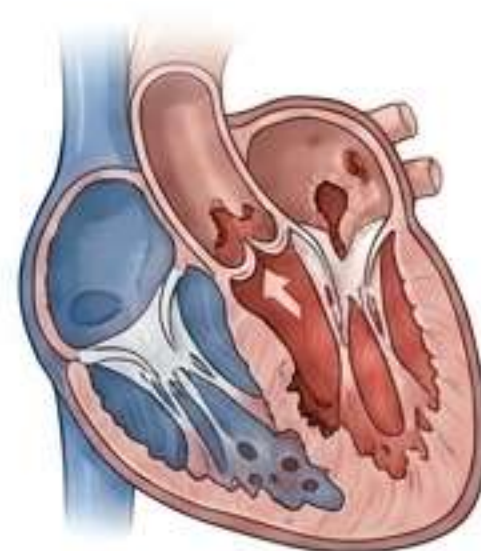
Les bactéries adhèrent sur l'endocarde et les valves et s'y multiplient.

Physiopathologie (2/2) : Formation et Conséquences

Formation de la lésion :

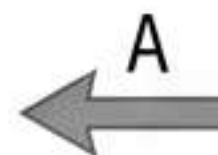


Il y a formation d'un amas conduisant à la formation de végétations infectées.

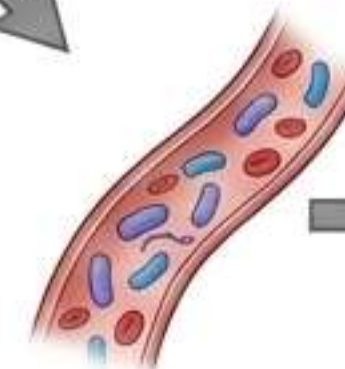


Ulcérations et perforations valvulaires

Conséquences Locales et Systémiques :



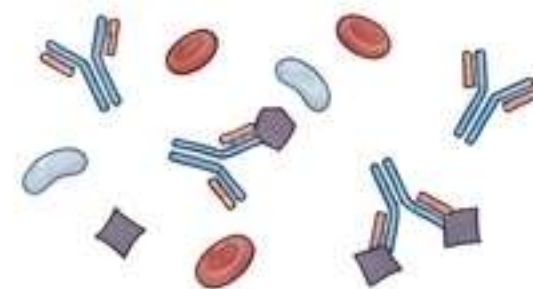
Défaillance cardiaque



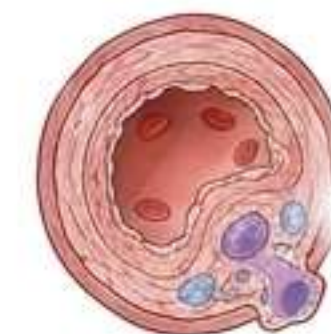
Essaimage sanguin

Risque de foyers secondaires et d'embolies

Conséquences Immunologiques :



Libération d'antigènes et de complexes immuns circulants

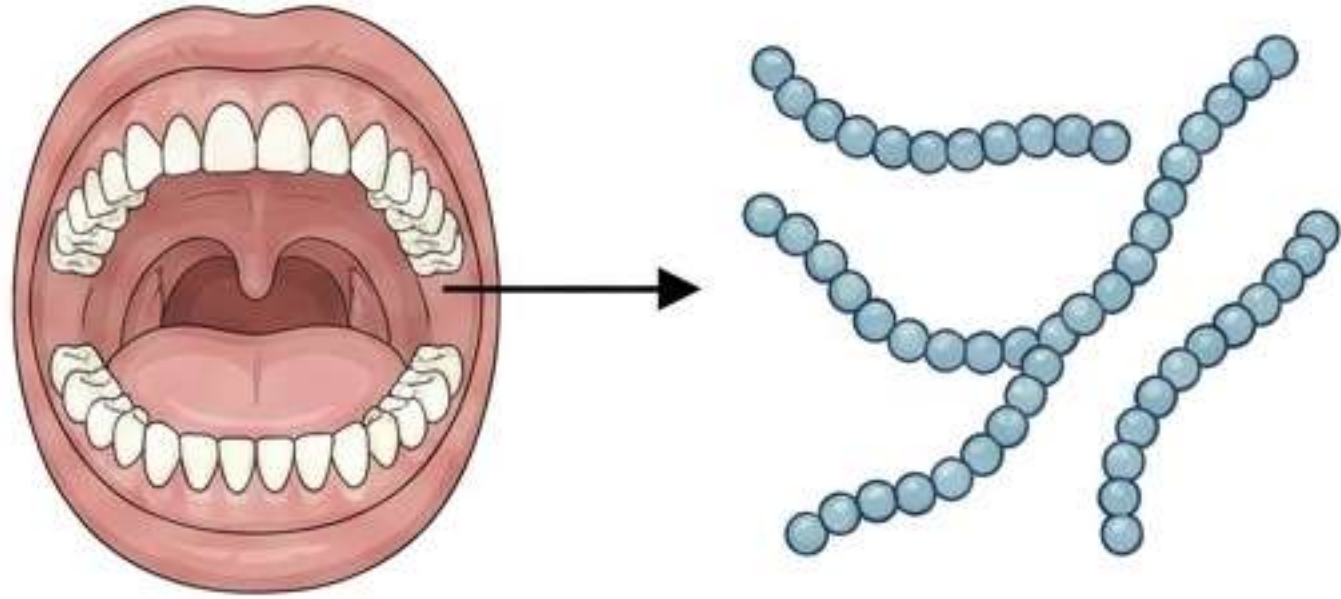


Des lésions de vascularite

Des manifestations immunologiques

Agents Étiologiques : Classification Majeure

1- Streptocoques oraux (origine buccodentaire) :

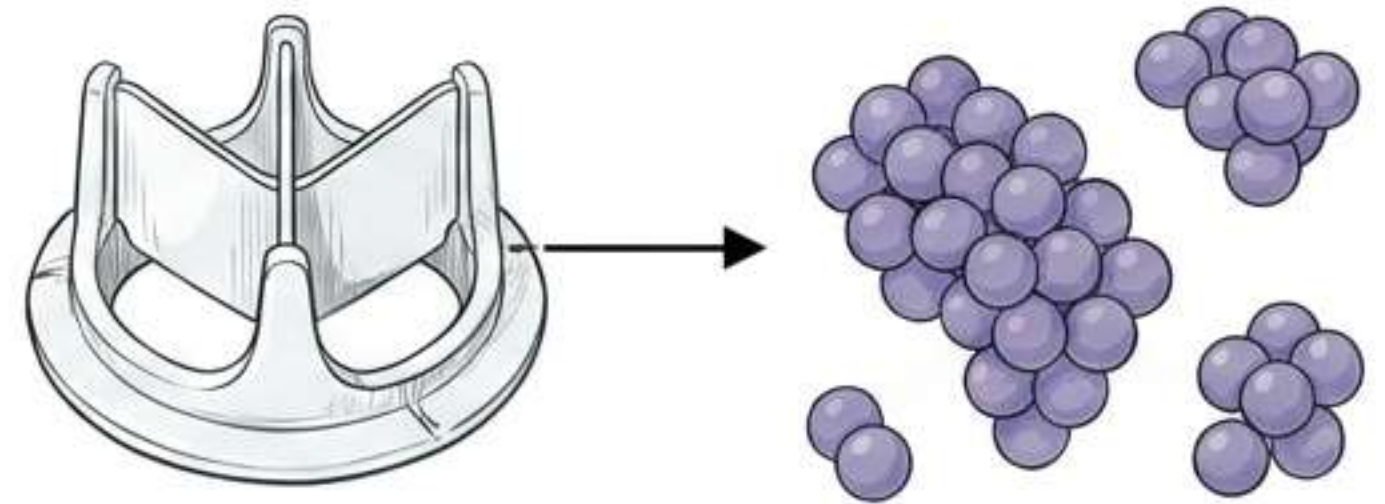


Contexte : Lors de pathologie buccodentaires ou de soins dentaires chez des patients ayant une pathologie cardiaque sous-jacente.

*Espèces incriminées :

- *Streptococcus mitis*
- *Streptococcus sanguis*
- *Streptococcus gordonii*

2- Staphylocoques :



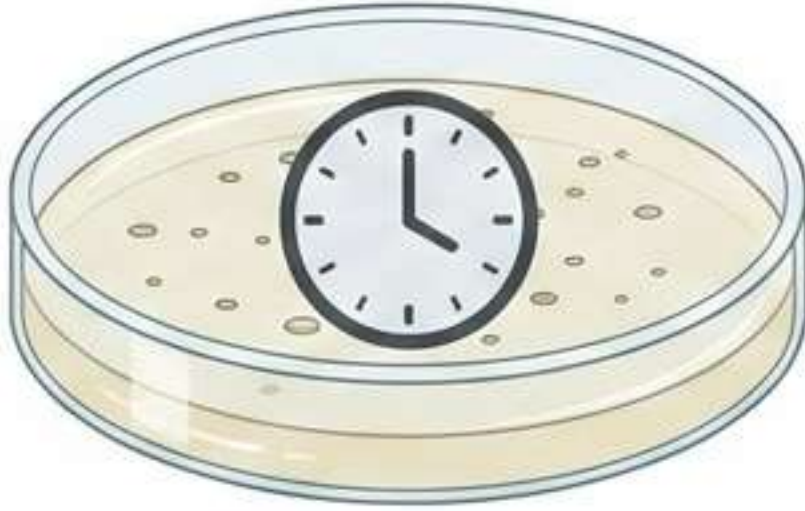
*Espèces :

- *Staphylococcus aureus* [Ref: EMD1-2022, Q16 - Fréquemment rencontrée comme agent d'infections nosocomiales]
- *Staphylococcus* à coagulase négative

Contexte : Surtout sur prothèse valvulaire ou valve native.

Agents Étiologiques : Bactéries Atypiques

3- Bactéries à croissance difficile ou lente :



- Streptocoques déficients (croissance difficile)
- Bactéries du groupe HACEK (croissance lente) : [Predicted]

Heamophilus

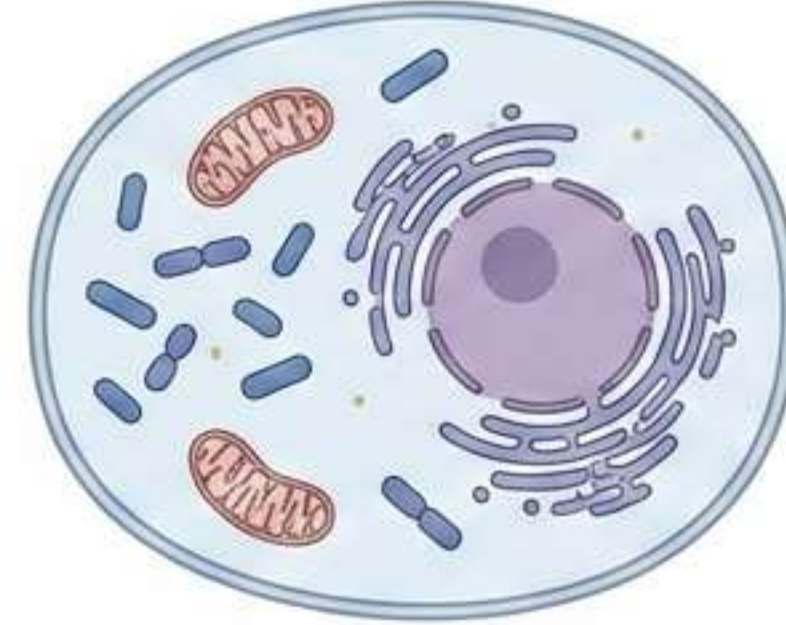
Actinobacillus

Cardiobacterium hominis

Eikenella corrodens

Kingella kingae

4- Bactéries à développement intracellulaire :

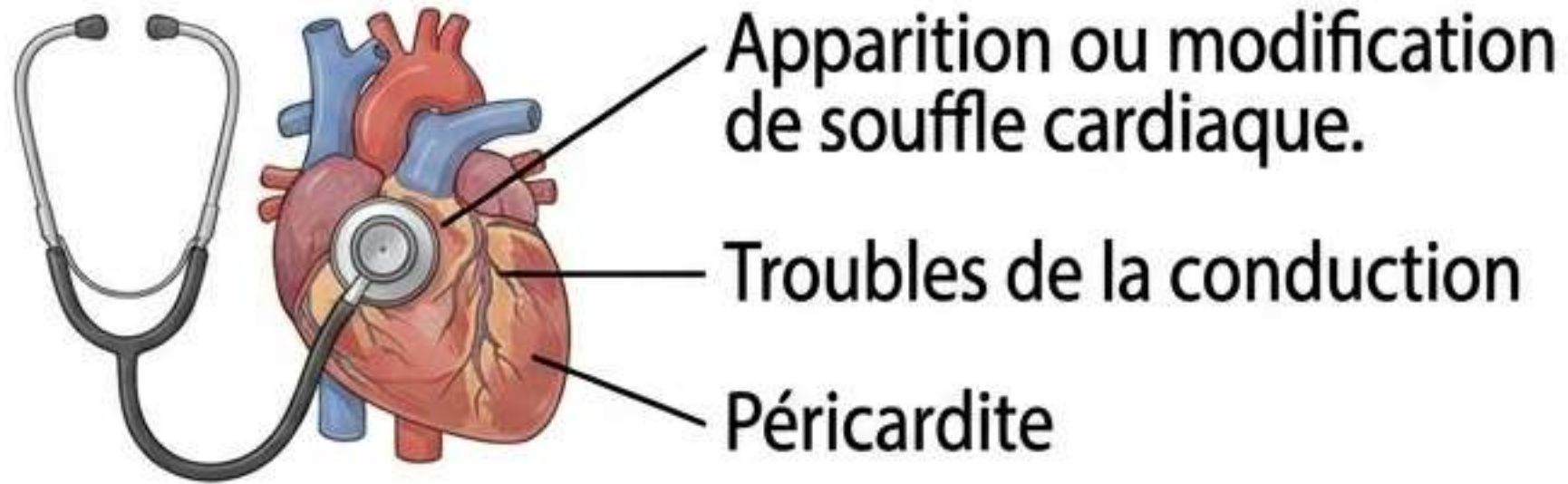


- *Brucella*
- *Coxiella burnetii*
- *Bartonella* sp
- *Tropheryma whippelii*

Diagnostic Clinique (1/2) : Cardiaque et Général

Les signes cliniques sont variés.

1. Signes cardiaques :



! RÈGLE CLINIQUE

Toute insuffisance cardiaque fébrile doit faire évoquer une endocardite infectieuse [Predicted]

2. Signes généraux :



Altération de l'état général

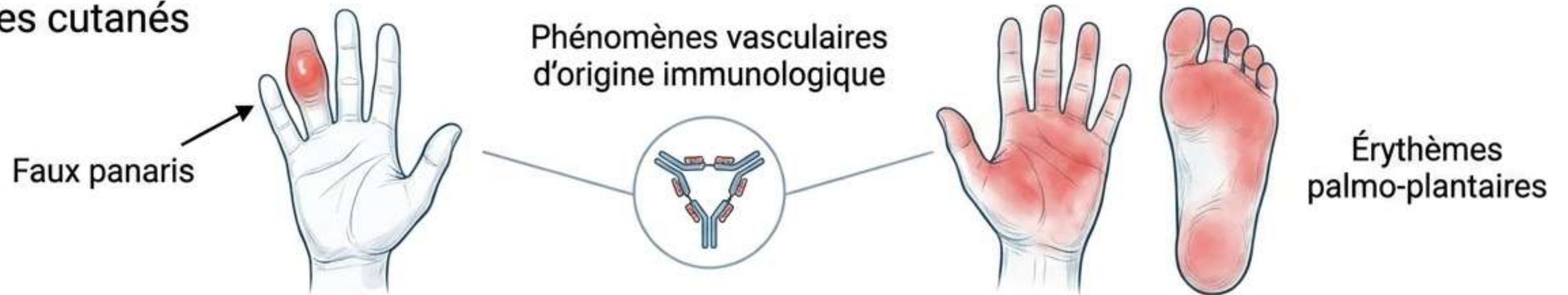
! RÈGLE CLINIQUE

Toute fièvre chez un sujet atteint de cardiopathie doit faire évoquer une endocardite infectieuse [Predicted]

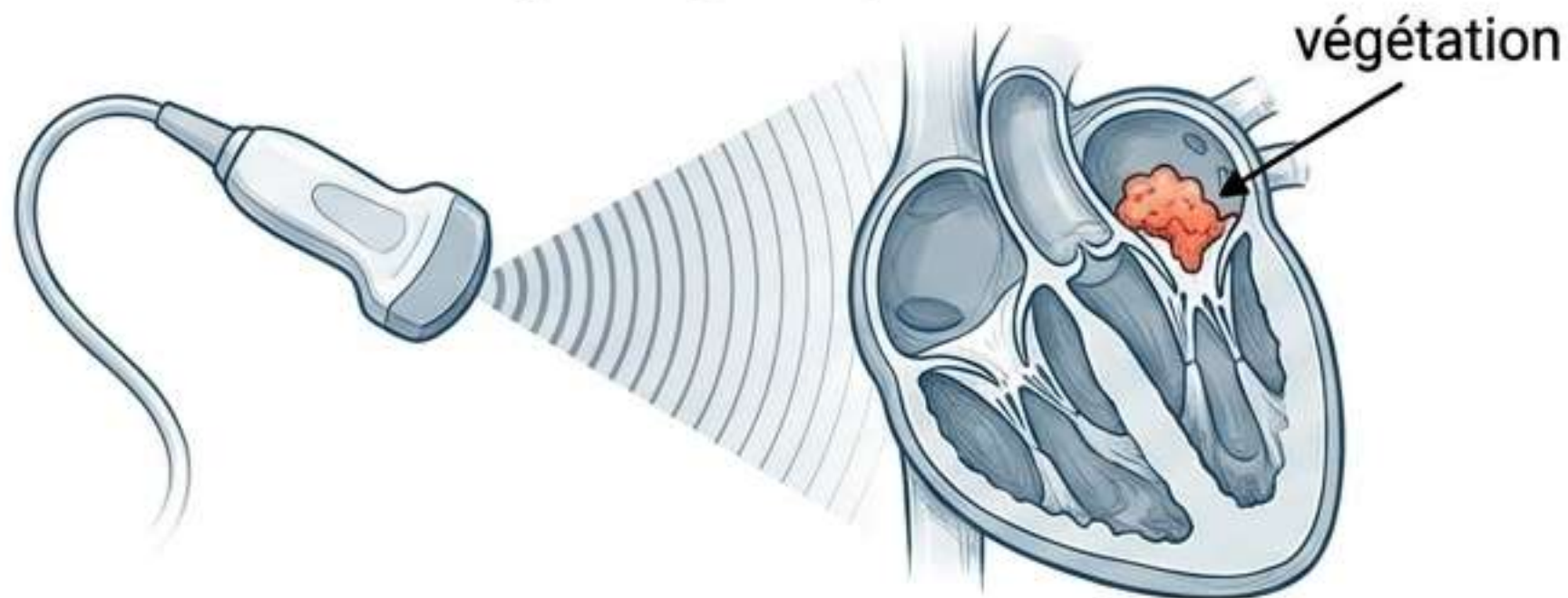
Diagnostic Clinique (2/2) et Imagerie

3. Signes extracardiaques :

- - Signes cutanés



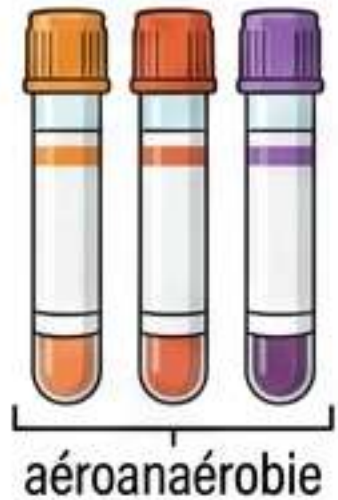
L'Examen Clé (Imagerie) :



L'échographie cardiaque est l'examen clé pour la mise en évidence des végétations.

Diagnostic Bactériologique : Protocoles

1. Hémoculture (Le standard d'or) :



(bactériémie
permanente)

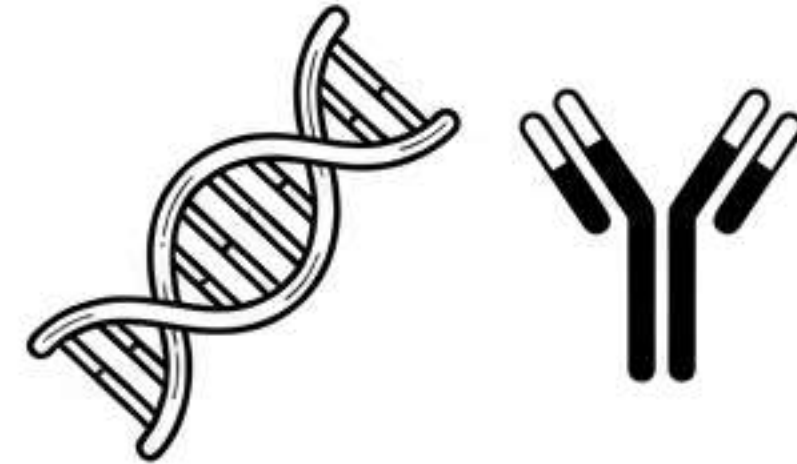


même en
absence
de fièvre



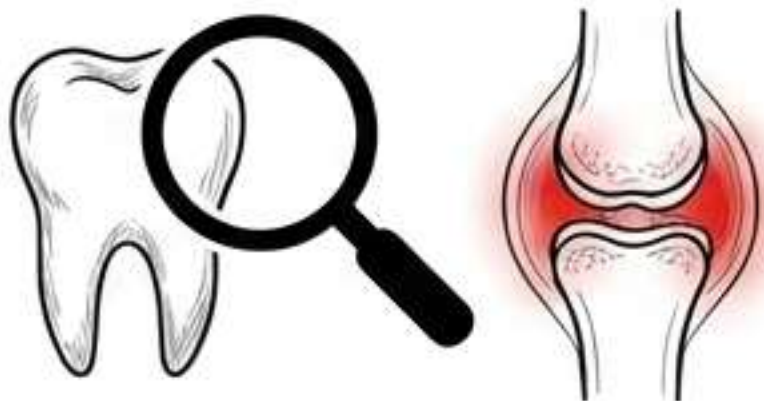
- Indiquée avant toute antibiothérapie. [Predicted]
- Réaliser 2 à 3 prélèvements distincts pour culture aéroanaérobie.
- Réaliser même en absence de fièvre (bactériémie permanente). [Predicted]

2. Sérologie et PCR :



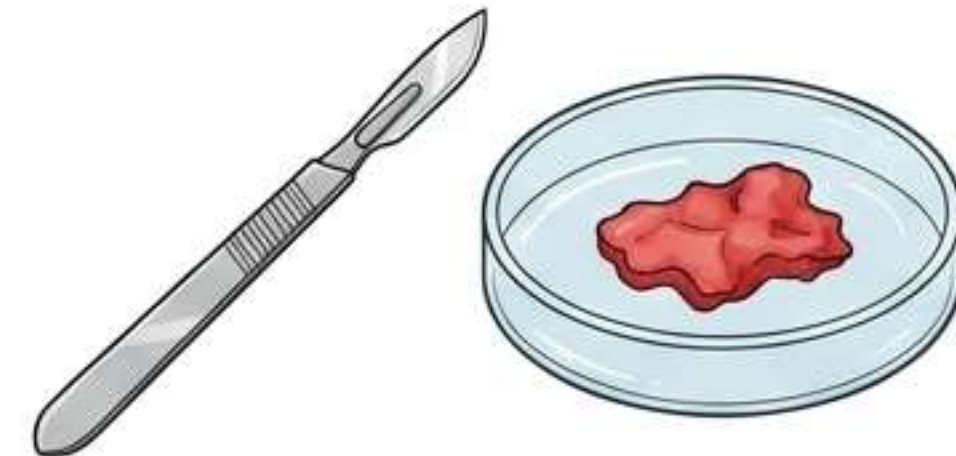
- Pour les bactéries intracellulaires (Coxiella, Bartonella).

3. Recherche de la porte d'entrée :



- Abscès, arthrite septique.

4. Chirurgie :



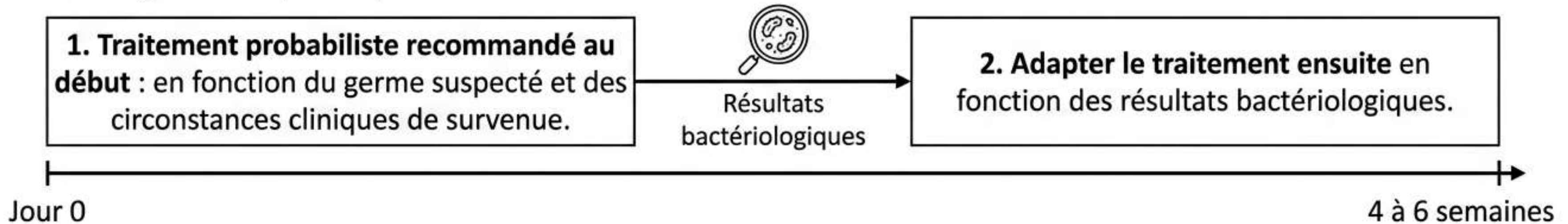
- En cas de chirurgie : culture du tissu de végétation.

Traitement Antibiotique

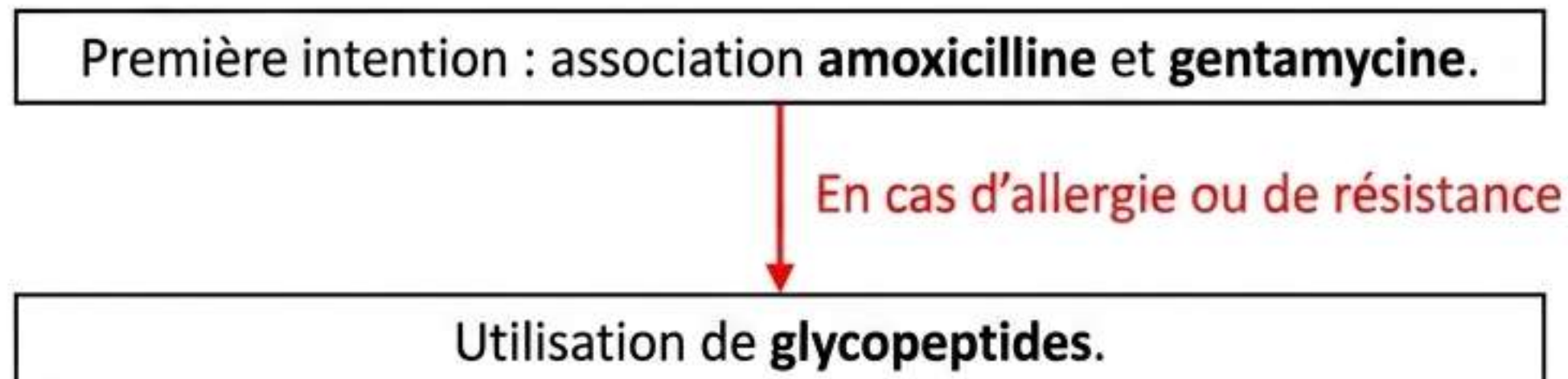
Caractéristiques du traitement :

Il doit être **bactéricide et prolongé (4 à 6 semaines)**. [Predicted]

Stratégie Thérapeutique :

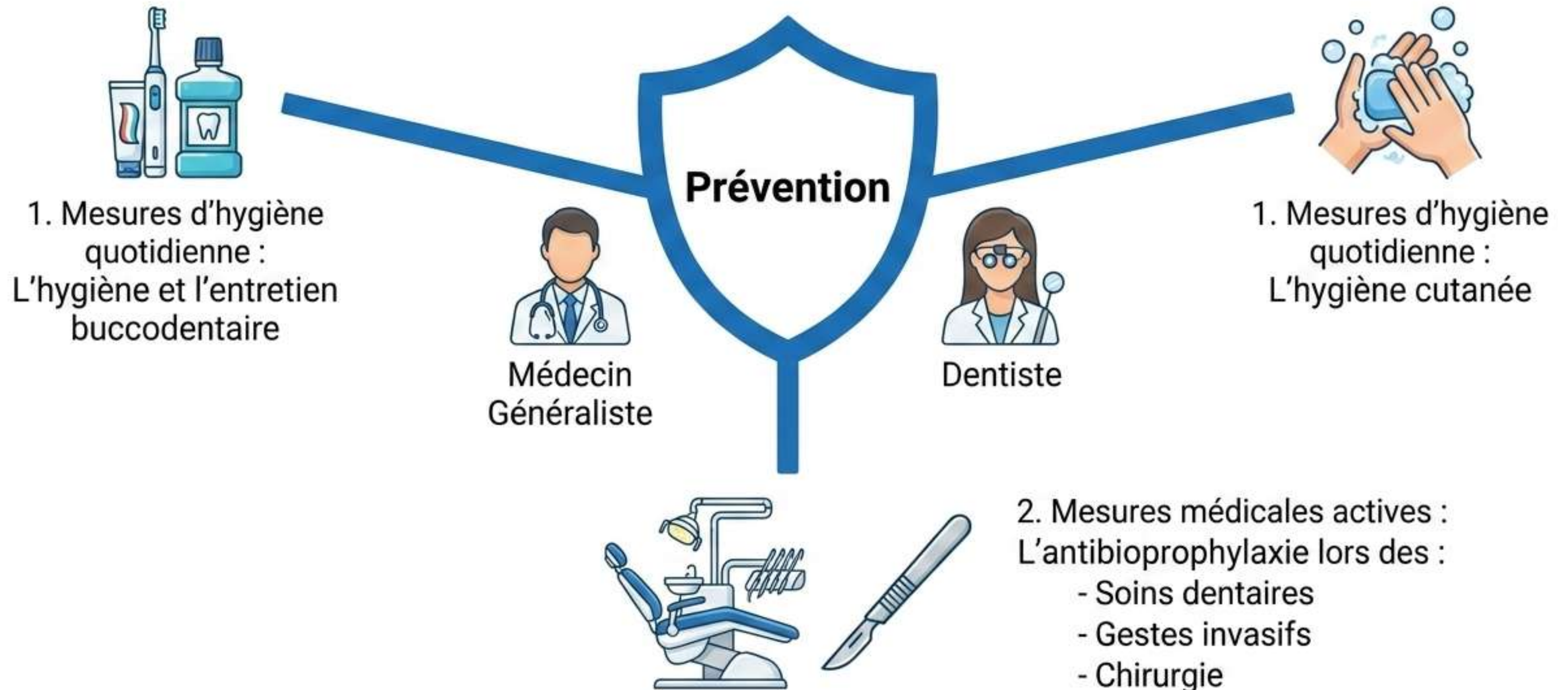


Exemple Clinique (Streptocoques oraux) :

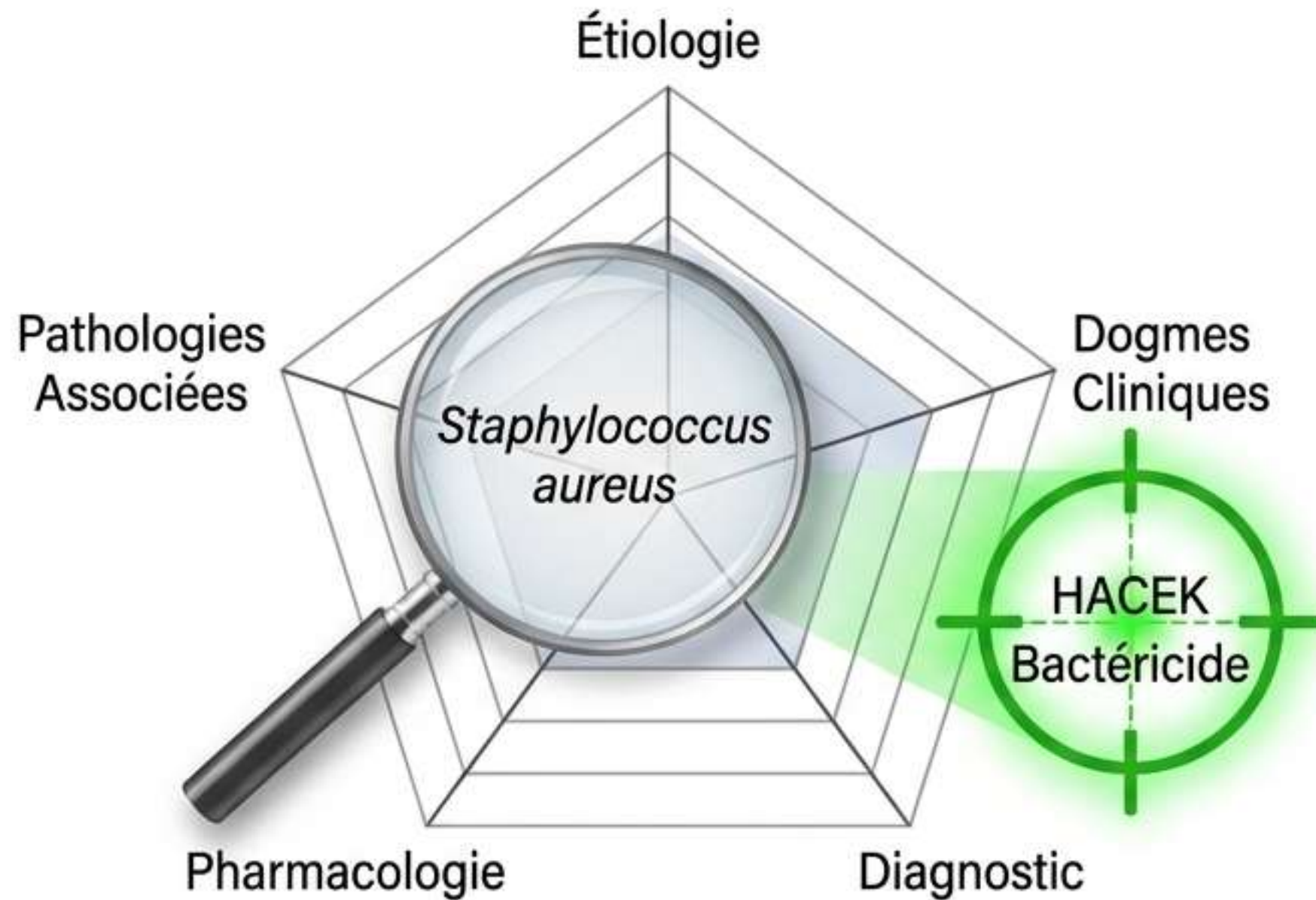


Prophylaxie et Prévention

Les médecins généralistes et les dentistes jouent un rôle essentiel dans la prévention.
Celle-ci se base sur trois axes :



Analyse des Modèles d'Examen (Exam Pattern Analysis)



- Sujets Répétés & Confirmés :

La classification des germes est la cible majeure. *Staphylococcus aureus* a déjà été testé [Ref: EMD1-2022, Q16] comme agent majeur des infections nosocomiales.

- Cibles à Haute Probabilité (Prédictions Futures) :

1. Nomenclature complexe : L'acronyme HACEK (*Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae*).
2. Dogmes Cliniques Absolus : Les phrases 'Toute insuffisance cardiaque fébrile...' et 'Toute fièvre... cardiopathie...' formulées de manière rigide, idéales
3. Protocoles Paracliniques : Hémocultures effectuées avant antibiothérapie et même sans fièvre.
4. Pharmacologie : Durée exacte (4 à 6 semaines) et nature (bactéricide).

- Pièges Potentiels :

Confondre les germes à croissance difficile (streptocoques déficients) avec ceux à croissance lente (HACEK).

Cartographie Mentale Récapitulative

